

Операция подвешивания влагалища

Информация для пациента · Восстановление опоры свода влагалища собственными тканями — без сетки

WARWIKI

Операция подвешивания влагалища устраняет пролапс (опущение) **свода влагалища или матки**, прикрепляя его к прочным связкам таза с помощью **собственных тканей** пациентки — без сетки. Выполняется полностью через влагалище, без разреза на животе; обеспечивает долговременный результат и сохраняет нормальную глубину влагалища.

Об этой операции

Свод влагалища подшивается к прочной тазовой связке, чтобы удерживать его на месте. Применяются два основных варианта:

- **Подвешивание к маточно-крестцовым связкам (USLS)** — фиксация к маточно-крестцовым связкам в глубине таза
- **Фиксация к крестцово-остистой связке (SSLF)** — фиксация к крестцово-остистой связке сбоку

В обоих случаях используются **собственные ткани** (постоянные швы) без сетки. Операция нередко сочетается с коррекцией передней или задней стенки влагалища; при удалении матки выполняется одновременно с гистерэктомией.

Сравнение с другими методами

По сравнению с **сакрокольпопексией** (которая поднимает влагалище с помощью абдоминальной сетки), вагинальное подвешивание исключает сетку и разрез живота; сакрокольпопексия может быть несколько более долговечной. Ваш хирург поможет взвесить все плюсы и минусы.

ТЕРМИНЫ

Апекс / свод

Верхняя часть влагалища, которая может опускаться при пролапсе.

Подвешивание

Повторное прикрепление свода влагалища к прочной связке.

USLS

Подвешивание к маточно-крестцовым связкам.

SSLF

Фиксация к крестцово-остистой связке.

Собственные ткани

Ваши собственные ткани — без сетки.

Пролапс свода

Опущение верхушки влагалища, нередко после гистерэктомии.

БУДЕТ ЛИ БОЛЬНО? Операция проводится под анестезией — во время неё вы ничего не чувствуете, разреза на животе нет. При варианте SSLF в первые дни или недели после операции может ощущаться **дискомфорт в ягодице или верхней части ноги** — он обычно проходит самостоятельно.

Как подготовиться

- Соблюдайте **указания по анестезии** (голодание, отмена антикоагулянтов по назначению).
- Пройдите предоперационное обследование; при необходимости могут быть добавлены другие коррекции или операция по лечению недержания мочи.
- Не курите; организуйте сопровождение домой и помощь в быту.

Что происходит

- 1 Вам вводят анестезию; назначают антибиотики.
- 2 Через влагалище свод подшивается к прочной тазовой связке.
- 3 По плану выполняются дополнительные коррекции стенок влагалища.
- 4 Устанавливается катетер, иногда на короткое время вводится вагинальный тампон.

После операции

- Выписка в день операции или на следующий день; небольшие кровянистые выделения — норма.
- **Избегайте тяжёлых нагрузок, натуживания и половой жизни около 6 недель.**
- Дискомфорт в ягодице (при SSLF) обычно проходит за несколько недель; следите за мягким стулом.

Обратитесь к врачу, если у вас:

- Повышение температуры или озноб, обильное кровотечение
- **Невозможность помочиться** или нарастающая тазовая боль
- **Сильная или простреливающая боль в ягодице / ноге**, новое онемение

ТРИ ВАЖНЫХ МОМЕНТА

1. Вагинальное подвешивание восстанавливает положение свода влагалища с помощью собственных связок — без сетки и разреза живота.
2. Основные варианты — USLS и SSLF; для сравнения существует сакрокольпопексия (сетка, разрез живота).
3. Избегайте нагрузок и половой жизни ~6 недель. Лёгкий дискомфорт в ягодице при SSLF возможен; при температуре, обильном кровотечении или сильной боли в ноге/ягодице обращайтесь к врачу.